

佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院

內科部臨床教學訓練計劃

【實習醫學生(UGY)】



UGY Teaching Program

Department of Internal Medicine

Tzu Chi General Hospital and Tzu Chi University

107 年 03 月編修

目 錄

壹、科部簡介	1
貳、訓練目標	1
參、教學師資	2
肆、教學資源	5
伍、訓練方式	5
陸、考評機制	17
柒、教學回饋	17
附件一、實習醫學生訓練考核表	18
附件二、實習醫學生對臨床教師回饋表	19
附件三、實習醫學生對科(部)教學回饋表	19

壹、科部簡介

內科學為臨床醫學的基本。內科部包含一般醫學內科、腸胃內科、心臟內科、腎臟內科、胸腔內科、新陳代謝及內分泌科、感染科、血液腫瘤科、風濕免疫科等 9 科及內科加護病房等醫療單位。此外，尚包含心導管室、心功能檢查室、肺功能室、支氣管鏡室、內科檢查室(內視鏡、腹部超音波檢查)及血液透析室等檢查治療單位。

本科部之發展特色為兼重基礎及臨床醫學。除提供病患高品質之服務外，更著重培養具有獨立診斷及分析能力之醫師，傳承「人本醫療、尊重生命」的精神，培育視病猶親的良醫。教學品質一流，專科錄取率優異。

歷任內科部主任為劉禎輝主任、陳瑞昌主任、楊治國主任、李仁智主任、林憲宏主任、王立信主任、鄭景仁主任、黃士哲主任、高瑞和主任、方德昭主任及現任陳健麟主任。

貳、訓練目標

一、訓練對象：

慈濟醫學院完成基礎課程，可進入臨床實習之醫學生或國內外經教育承認之醫學院相當等級之醫學生經院方核可者，均可於本院實習。

二、訓練期間：

依慈濟大學醫學系課程委員會規定。

三、訓練目標：

為達成以病人為中心的照護理念，依據美國畢業後醫學教育委員會 Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) 六項之醫學教育教學目標，

制定訓練目標如下：

1. 使學生學習及具備內科學基礎知識，包含內科學常見症狀及徵候、病態或疾病等。
2. 指導學生熟悉內科學臨床技能。包含內科學常見理學檢查、心電圖及影像學判讀及實驗診斷技巧與判讀等。

3. 培養學生主動學習及終身學習之精神。
4. 以病人照護為中心，利用病人問題導向自我學習。
5. 利用實證醫學資訊查詢方法以解決病人問題。
6. 培養跨專業、跨領域團隊合作。
7. 學習與病人及病人家屬相處及建立良好醫病關係。

目標達成之方式：

1. 病人照護 (Patient care)：分組照護病人、參加交班會議、晨會、討論會、教學迴診等。
2. 醫學知識 (Medical knowledge)：備多項參考書、電子圖書及訓練教材(教學部網站<http://10.2.3.8/TWeb/pgm/index.asp>)，定期口試與筆試等。
3. 學習與改善 (Practice-based learning and improvement)：舉辦雜誌討論會、臨床病例討論會，不良事件研討會、導師輔導等。
4. 照護系統學習 (systems-based learning)：定期舉辦科際討論會、全院學術演講活動中安排跨領域團隊之主題研討會。
5. 溝通技巧(Communication skills)：教師研習營，標準化病人演練，全人醫療會議、導師輔導等。
6. 敬業精神(Professionalism)：導師輔導、交班確實、倫理問題研討、醫療法律問題研討。

參、教學師資

本部現有 53 位專任主治醫師及 15 位住院醫師及 3 位客座師資。

一般醫學內科專任主治醫師有 7 位，心臟內科專任主治醫師有 10 位，腸胃內科專任主治醫師有 8 位，腎臟內科專任主治醫師有 6 位，胸腔內科專任主治醫師有 6 位，新陳代謝內分泌科專任主治醫師有 3 位，感染科專任主治醫師有 3 位，血液腫瘤科專任主治醫師有 5 位，風濕免疫科專任主治醫師有 2 位及內科加護病房專任主治醫師有 3 位。本部師資目前有部定教授 4 名、部定副教授 8 名、部定助理教授 10 名、部定講師 3 名及客座教授 3 名。

美國喬治華盛頓大學張步良教授協助規劃一般內科教學。張步良教授邀請華裔美國約翰霍浦金斯內科教授徐達雄輪流至本院一般內科病房教學，每位教授春秋各

來院指導一個月，自 95 年 10 月起為期 4 年，每年共 4 個月，希望建立良好之一般內科訓練計畫。

內科主任：陳健麟

教學計畫負責人：張恩庭

客座教授：

張步良教授 (Paul Chang) 美國喬治華盛頓大學內科教授

徐達雄教授 聖馬修醫學院內科教授、內科主任，美國約翰霍浦金斯內科副教授

王正一教授 台灣大學醫學院內科教授

內科部主治醫師：

心臟內科：王志鴻、鄭景仁、謝仁哲、陳郁志、劉維新、蔡文欽、朱新凱、
張懷仁、楊秋芬、蔡劭謙。

感染科：王立信、何愉懷、鄭順賢。

風濕免疫科：蔡世滋、蘇桂英、潘郁仁(兼任)。

血液腫瘤科：朱崧肇、王佐輔、吳懿峰、黃威翰、李啟誠。

新陳代謝科：吳篤安、陳信典、李哲全。

腸胃內科：胡志棠、陳健麟、劉作財、易志勳、雷尉毅、林振雄、洪睿勝、
翁銘炆。

腎臟內科：徐邦治、王智賢、賴宇軒、林子立、郭秋煌、徐儒將。

胸腔內科：林智斌、李仁智、楊治國、劉迪塑、張恩庭、胥愛璽。

一般醫學內科：林彥光、謝明蓁、潘郁仁、羅文綾、李璐佳、鄭先安、葉大川。

內科加護病房：陳逸婷、吳雅汝、莊立良。

主治醫師職責：

1. 監督住院醫師/Intern/Clerk之病人照護及教學。
2. Intern之教學及考核表（附件一）
3. Clerk 之教學及考核表（附件一）

主治醫師職責：

1. 監督住院醫師/Intern/Clerk之病人照護及教學。
2. Intern之教學及考核表（附件一）
3. Clerk 之教學及考核表（附件一）

肆、教學資源

一、設施：

教學病房—內科部設有一般內科病房於五東、二六東、二六西、二七東、二八東、二八西、二十東、二十一東、六西病房及 MICU，床數約 262 床。學員與住院醫師組成醫療團隊，每組醫療團隊含一位主治醫師，一位住院醫師，及一或二位 clerks，在主治醫師指導及病房總醫師輔導下照護病人。

二、設備：

1. 心臟科: HP5500 型彩色心臟超音波機、體表心電圖、24 小時心電圖記錄器、運動心電圖機等。
2. 腸胃科: 電子彩色內視胃鏡、纖維內視鏡、彩色都卜勒超音波、一般超音波、電灼裝置、瘰肉切除機、血氧濃度監測機、膽管碎石器、膽管取石器、食道靜脈瘤結紮器、汎內視鏡、大腸鏡、食道酸鹼度儀(24 小時)、食道擴張器、碳-13 尿素呼氣測試儀等。
3. 胸腔內科: 超音波、肺功能檢測室、支氣管鏡、呼吸器、睡眠中心、呼吸治療中心等。
4. 腎臟科: 血液及腹膜透析中心。
5. 一般內科: 臨床技能中心、標準病人示範中心。
6. 血液腫瘤科: 骨髓幹細胞中心、癌症治療中心。
7. 新陳代謝科及內分泌科: 糖尿病衛教中心。

伍、訓練方式

一、訓練方式：

1. 教學活動有床邊教學、門診教學、晨會、討論會。運作為設有一般內科訓練病房設於五東、二五西、二六東、二六西、二七東、二八西、二十東、二十一東、六西病房及 MICU。學員與住院醫師組成醫療團隊，每組醫療團隊含一位主治醫師、一位住院醫師，一或二位 clerks，在主治醫師指導及病房總醫師輔導下照護一般內科病人，學習一般內科常見疾病。

2. 安排夜間及過夜實習訓練：學習病房緊急及值班事項的處理。

2.1 醫六實習期間每一梯每週安排過夜學習一天，時間為下午五點三十分至隔日早上八點，並於實習第一天前將選定之過夜學習班表繳給CR，並張貼於病房公佈欄，以便查核。

2.2.1 過夜學習內容與方式：由內科值班醫師做為UGY第一線指導，以值班照護範圍患者學習。第二天學生可根據內科部規定休假。

三、具體教學計畫：

1. 處理臨床問題的能力：

分組照護病人、參加交班會議、晨會、討論會、教學迴診、標準病人演練、導師輔導、定期口試與筆試。

2. 溝通能力：

標準病人演練，教學迴診，導師輔導等。

3. 照顧病人的責任：

交班確實、倫理問題研討、醫療法律問題研討，導師輔導等。

四、臨床教學課程

1. 臨床技能教學

◆ 由教學部安排

2. 住診教學（含床邊教學）

◆ 各病房每月 10-12 次住診教學（含床邊教學）

3. 實證醫學教學

◆ 舉辦雜誌討論會

◆ 臨床病例討論會

◆ 實證醫學教學（一般醫學內科病房）

4. 病歷寫作教學

◆ 主治醫師及住院醫師依住院及門診病人病歷寫作病歷教學

◆ 客座教授病歷寫作教學

5. 醫學倫理教學

- ◆ 倫理問題研討
 - ◆ 醫療法律問題研討 (一般醫學內科病房)
6. 理學檢查教學
- ◆ 心血管管理學檢查教學
 - ◆ 肺音教學
7. 基礎影像及心電圖教學
- ◆ 胸部X光判讀教學
 - ◆ ECG教學

五、實習醫學生 (clerk) 每日學習計畫

1. 在上級醫師指導下診察病人，寫Progress Note。
2. 每日跟隨上級醫師巡查病房。
3. 在上級醫師指導下，學習臨床診斷及治療原則。
4. 參加各種學術討論會、教學演講。
5. 臨床實習應以學習為目的，並加入醫療團隊照顧病人，依學生能力安排適量病人數，採"循序漸進"之原則安排，由照顧1床住院病人開始，再依能力增加到4人。

六、醫療團隊

1. 每位住院醫師固定12-15床，每位住院醫師跟固定的1-3位主治醫師。病房總醫師輔導教學。每一位住院醫師帶1-2位Clerk。
2. Clerk依實習排程課程安排更換實習科別。，Clerk (六年級)以照護3-6 床為限，醫療需於住院醫師/主治醫師監督下進行。
3. 學習如何成為醫療團隊中的一份子，並尊重護理人員及相關同仁。
4. 實習醫學生若於實習期間發生身體不適，需報告總醫師，由總醫師反應給師長及科主任，或請同組同學代為報告行蹤，才可返家休息；如情況嚴重，可請科內人員協助送醫並予適當關懷。

七、病房分配

病房分配如下(每1病房約40床)：

五東：血液腫瘤科、腎臟內科

六西：一般醫學內科

二六東：胸腔內科、一般醫學內科

二六西：心臟內科

二八東：腸胃內科、感染科、新陳代謝及內分泌科、風濕免疫科

二八西：腎臟內科

二十東：胸腔內科

二十一東：胸腔內科(TB病房)

八、實習時數之安排

實習時數之安排依照衛福部來函”實習醫學生臨床實習指引”(中華民國 102 年 7 月 8 日臺教高(五)字第 1020099038 號函)規定辦理，有關實習時數之安排應適宜，其原則如下：

- i. 四週實習值勤時間平均不得超過每週八十小時，單週不得超過八十八小時。
- ii. 實習醫學生每日例行實習值勤時間不得超過十二小時，兩次實習值勤時間中間至少應有十小時以上休息時間。連續實習值勤總時間不得超過三十二小時（白班實習時數＋夜間值勤實習時數），並得於夜間實習執勤後依當時工作量及身心情況，向總醫師或實習指導醫師提出以下需求（三選一）；總醫師應予配合調度人力支援。
 - 甲、連續休息二小時後再接續執勤實習。
 - 乙、完全不接新病人。
 - 丙、接二位(含)以下新病人。
- iii. 總醫師或實習指導醫師得視以下情況，延長實習醫學生之實習時數：
 - 甲、基於病人安全考量須持續照顧。
 - 乙、臨床實習過程之完整性。

九、內科部教學活動表

3 10 17 24 (星期一)	4 11 18 25 (星期二)	5 12 19 26 (星期三)	6 13 20 27 (星期四)	7 14 21 28 (星期五)
◆內科部綜合性晨會 時間：08:00~09:00(4/3 暫停召開) 地點：協力 2 樓和氣會議室 主持人：總醫師/陳健麟主任 報告者：週六、週日值班住院醫師 參加人員：所有 R、一般醫學內科 PGY、Intern、Clerk、NP 指導人員：週六、週日值班的主治醫師	◆內科部臨床討論會 死亡併發症討論會 時間：08:00~09:00(4/4 暫停召開) 地點：協力 2 樓和氣會議室 主持人：陳健麟主任 主要指導者：陳健麟主任 參加人員：VS、R、Intern、Clerk、NP (4/25 部務會議，Intern、Clerk 不用參加)		◆全院學術討論會 時間：07:30~08:30 地點：協力樓 1 樓協力講堂	
				◆王正一教授教學 時間：11:00~12:00 地點：602 教室(4/7、4/21) 主持人：王正一教授 報告者：王正一教授 主要指導者：王正一教授 參加對象：R、Intern、Clerk
	◆ECG Didactic and Workshop 時間：14:00~15:30 (4/11、4/18) 地點：601 教室 主持人：黃水坤 教授 主要指導者：黃水坤教授 參加人員：Intern、Clerk			

十、內科各項討論會

科別	名稱	內容
全院	全院學術演講	以專題方式，邀學有專長者演講，主題涵蓋全人醫療、病人安全、醫療品質、醫病溝通、醫學倫理、醫事法規、感染管制、實證醫學及病歷寫作。
科際	臨床病理討論會(CPC) 每三個月一次	由臨床醫師分析，對照影像結果，與病理科醫師共同討論病人的診斷、及病理生理學。
科際	大內科討論會 (Grand Round)	共同研討有關診療疑難之病例與改進診療技術方法。報告醫師應負責病人資料之準備，病歷報告，並記錄討論內容。開會前並應學習文獻之索引，查閱有關文獻，在討論會上練習報告。
科際	胃腸內外放射腫瘤病理 聯合討論會	由胃腸內科醫師分析，與外科、放射腫瘤科及病理科醫師共同討論病人的診斷及進一步診療。
科際	胸腔科影像病理聯合討 論會	與放射線科醫師共同討論影像檢查之異常，並且印證臨床檢查之結果，以增加影像分析能力。
科際	腫瘤病理聯合討論會	由臨床腸胃內科、外科分析與血液腫瘤科醫師、放射科及病理科醫師共同討論病人的診斷及進一步診療。
內科	ECG 教學	由心臟科醫師作心電圖教學
內科	胸部 X 光教學	由胸腔內科醫師作胸部 X 光教學
內科	死亡及併發症討論會	討論發生死亡及併發症之病例，著重於檢討，以期避免發生類似併發症，並減少死亡率。
內科	病房晨會及綜合性晨會	由主治醫師總醫師主持，討論新入院病患及有重要病況改變之住院病患。
加護病房	跨領域團隊會議(IPPC)	藉由跨團隊討論及合作，討論如何共同照護加護病房患者。
各次專科	各科讀書會	由各主治醫師輪流提供各專題有關文獻，報告醫師閱讀後提出心得報告，並與主治醫師互相討論，以充實學識。

十一、醫學系實習醫學生於內科實習時臨床技能要求如下：

學員	技能	類別	訓練內容	評估方式	Level
Clerk	測量血壓 (Blood pressure measurement)	身體診察的技巧(Physical Examination)	1. 會使用各種血壓計測量血壓。 2. 選擇適當的壓脈帶尺寸，並圍繞於手臂。 3. 測量病人躺姿、坐姿或站姿之血壓。 4. 注意雙側或上下肢血壓是否不同。 5. 判讀血壓結果並了解其臨床意義。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	V
Clerk	測量體溫 (Body temperature measurement)	身體診察的技巧(Physical Examination)	1. 會使用各種方式測量體溫。 2. 使用體溫計測量體溫，並判讀其臨床意義。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	V
Clerk	心血管系統的檢查 (Cardiovascular system examination)	身體診察的技巧(Physical Examination)	1. 使用視診、觸診、扣診及聽診等方法，依序進行心血管系統的檢查。 2. 觀察頸靜脈波，並評估中心靜脈壓高度，在心尖處能評估最大脈點 (PMI) 位置及大小。 3. 觸診頸動脈、桡動脈、股動脈、臍動脈、脛動脈、足背動脈。檢測脈搏的頻率、節奏、對稱、強弱並檢查心尖搏動與顫動 (heave & thrill)。 4. 扣診檢測心臟大小。 5. 使用聽診器，執行心臟四個部位心音的聽診，並分辨各種不正常心音及其臨床意義。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	V
Clerk	頸部及甲狀腺的檢查 (Neck examination including thyroid gland)	身體診察的技巧(Physical Examination)	1. 使用視診、觸診及聽診等方法，執行頸部及甲狀腺的檢查。 2. 以觸診方式檢查頸部之淋巴結或腫塊 (包括其特徵，如位置、大小、硬度(consistency)、移動性、疼痛)。 3. 分辨正常或異常的甲狀腺。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	V
Clerk	咽喉的檢查 (Oropharyngeal examination)	身體診察的技巧(Physical Examination)	1. 使用壓舌板檢查口咽各構造包括：舌部、口底、軟硬腭、頰部及咽部黏膜及扁桃腺。 2. 觀察並詢問病人，咽喉檢查過程中，是否有不適反應。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	V
Clerk	腹部的檢查 (Abdominal examination)	身體診察的技巧(Physical Examination)	1. 依序使用視診、聽診、觸診及扣診方法進行檢查。 2. 視診包括腹部外表之異常。 3. 聽診檢查包括描述各部位腸蠕動音及異常血液流動聲。 4. 觸診腹部器官及偵測腹部壓痛部位與程度。 5. 扣診檢查腹部器官大小、會分辨鼓音及實質音。 6. 觀察並詢問病人腹部檢查過程中，是否有不適反應。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	V

學員	技能	類別	訓練內容	評估方式	Level
Clerk	腹股溝的檢查 (Inguinal examination)	身體診察的技巧(Physical Examination)	1.辨認腹股溝體表的解剖特徵及兩側對稱性。 2.辨認皮膚外觀是否完整、有無潰瘍或不正常突起。 3.使用觸診偵測淋巴結、腫塊及膨出物，並詢問是否疼痛。 4.觀察並詢問病人，腹股溝過程中，是否有不適反應。 5.檢查過程能注意病人隱私及感受。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	V
Clerk	直腸指診 (Rectal examination)	身體診察的技巧(Physical Examination)	1.說明直腸指診的檢查姿勢及程序。 2.進行肛門及周圍外觀病變之診視。 3.進行完整 360 度指診動作。 4.描述指診發現及有無壓痛。 5.檢查過程能注意病人隱私及感受。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV
Clerk	體液狀態的評量 (Assessment of hydration/volume (body fluid status))	身體診察的技巧(Physical Examination)	1.說明正常的體液組成狀態及調控因素。 2.執行病史詢問及身體診察，判斷體液狀態 (Euvolemic/ Hypovolemic/ Hypervolemic) 3.由相關檢驗數據，判斷異常體液狀態。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV
Clerk	死亡確認 (Confirmation of death)	身體診察的技巧(Physical Examination)	1.說明死亡的定義。 2.判定病患無意識、無呼吸、無心跳、瞳孔無光反射。 3.判定病患心電圖之心律為無收縮 (asystole)。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV
Clerk	基礎心電圖的判讀 (Interpret an ECG)	心電圖及影像學的判讀 (Image Interpretation)	1.說明心電圖檢查的適應症及禁忌。 2.具備心電圖生理學知識。 3.確認心電圖病人姓名、檢查日期及導極正確性。 4.系統性描述心電圖，並指出不正常型態及特性。 5.判讀常見的異常心電圖，並且列出鑑別診斷。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV
Clerk	基礎腹部 x-光影像的判讀 (Interpret an abdominal radiograph)	心電圖及影像學的判讀 (Image Interpretation)	1.說明腹部 x-光檢查的適應症及禁忌。 2.具備基礎放射學及腹部解剖學知識。 3.確認 x 光片病人姓名、檢查日期及 x 光片方向 (orientation)。 4.系統性的描述腹部 x-光影像，並指出病灶之型態及特性。 5.判讀常見的腹部疾病 x-光影像，並且列出鑑別診斷。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV
Clerk	安全的檢體處理 (Safe handling of specimen)	實驗診斷的技巧 (Laboratory Exam)	1.說明安全的檢體處理標準防護措施及感染控制對策。 2.穿戴防護用具。 3.執行檢體採集和安全處理感染性廢棄物。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	V

學員	技能	類別	訓練內容	評估方式	Level
			4.執行如何避免針扎，以及說明發生針扎事件後之處理流程。		
Clerk	標明檢體 (Label specimen)	實驗診斷的技巧 (Laboratory Exam)	1.作適當的病人辨識。 2.檢體作適當標籤，包括病人姓名、病歷號碼，或檢體別。 3.按照基本作業，備血檢體上需採檢人及見證人簽名。		V
Clerk	尿液試紙測驗 (Urine dipstick test)	實驗診斷的技巧 (Laboratory Exam)	1.說明執行尿液試紙測驗之適應症。 2.說明各項尿液試紙測驗的意義及判讀異常值。 3.運用結果於各種常見臨床疾病。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	V
Clerk	檢體的儲存 (Specimen storage by its different nature)	實驗診斷的技巧 (Laboratory Exam)	1.執行病人辨識及採檢檢體的標示。 2.選擇及操作試管、容器以及收集各種檢體。 3.適當處理、包裝、保存，並適時運送檢體。 4.說明不當收集儲存的檢體，對檢驗結果可能產生的影響。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	V
Clerk	攜帶型血糖測量 (Portable blood glucose measurement)	實驗診斷的技巧 (Laboratory Exam)	1.說明執行血糖測量之適應症。 2.操作攜帶型血糖機測量血糖，並說明測量血糖時，可能產生誤差之原因。 3.完成病人皮膚消毒、採血及傷口處理。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	V
Clerk	革蘭氏細菌染色 (Gram stain)	實驗診斷的技巧 (Laboratory Exam)	1.說明革蘭氏染色適應症與抹片製作方法。 2.執行革蘭式染色步驟。 3.判讀抹片結果。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV
Clerk	嗜酸快速染色 (Acid-Fast stain)	實驗診斷的技巧 (Laboratory Exam)	1.說明嗜酸快速染色適應症與抹片製作方法。 2.執行嗜酸快速染色步驟。 3.判讀抹片結果。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV
Clerk	血液抹片 (Blood smear)	實驗診斷的技巧 (Laboratory Exam)	1.說明執行血液抹片的適應症。 2.採血、製作血液抹片及染色。 3.分辨不正常之紅血球、白血球(含分類)及血小板。 4.判讀常見血液疾病，並列出鑑別診斷。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV
Clerk	a 基本的急救 (Basic life support, BLS)	操作型技巧 (Procedural Skills)	1.說明生存鏈的意義 (Chain of Survival)。 2.能依照最新版心肺復甦術 (CPR) 流程實施 CPR。 3.呼吸道的初步處理(包括呼吸道異物阻塞的排除)。 4.了解體外自動電擊器(AED)的操作，並能因應不同情境以適當順序，整合操作上述急救動作。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	V
Clerk	b 高階的急救	操作型技巧	1.熟悉各種危急狀況心電圖 (諸如：心	評分表	III

學員	技能	類別	訓練內容	評估方式	Level
	(Advanced life support, ACLS)	(Procedural Skills)	跳停止之心律、各種頻脈/緩脈心律、急性心肌梗塞心電圖等)。 2.說明去顫電擊術(Defibrillation)與同步整流術(Synchronized Cardioversion)的意義及使用時機。 3.知道各種急救藥物及設備之使用。 4.知道各種高級急救生命術處理流程。	OSCE 模擬考 模擬病人	
Clerk	12 導極心電圖操作 (Put on ECG(12-lead leads))	操作型技巧 (Procedural Skills)	1.說明各導極置放之正確解剖位置。 2.熟悉心電圖機之正確操作。 3.將導極置放至正確位置,並記錄心電圖。 4.各種障礙的排除。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	V
Clerk	不同部位的注射技巧(含皮內/皮下/肌肉/靜脈) (Injection)	操作型技巧 (Procedural Skills)	1.說明各種部位注射的適應症與方法。 2.執行部位消毒。 3.進行皮下/肌肉/靜脈注射操作,並遵守病人安全規範。 4.有效防止及處理各種注射的相關併發症。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV
Clerk	靜脈導管的置放 (Put on IV catheter)	操作型技巧 (Procedural Skills)	1.依注射目的的不同,正確準備用物。 2.選擇注射部位。 3.執行部位的消毒。 4.依注射要點,以無菌技術,正確置放靜脈留置針,並提供後續之照護。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV
Clerk	靜脈穿刺及血液細菌培養 (Veno-puncture and blood culture)	操作型技巧 (Procedural Skills)	1.說明血液檢體採取、儲存與傳送相關之安全事項。 2.依據標準步驟,在適當部位消毒及執行靜脈穿刺。 3.說明執行血液細菌培養的時機與意義。 4.說明血液細菌培養需要的血量,套數與血液培養細菌之種類。 5.無菌的執行將抽出之血液檢體,注入血液培養瓶中。 6.適當的壓迫抽血處,進行止血。 7.分辨血液培養之菌種為汙染菌,而非真的致病菌。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV
Clerk	動脈穿刺的技巧 (Arterial puncture)	操作型技巧 (Procedural Skills)	1.說明抽取動脈血的適應症及併發症。 2.正確找到橈動脈,作為穿刺的位置。 3.熟悉動脈穿刺的流程。 4.正確判讀動脈血液分析之結果。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV
Clerk	插鼻胃管的技巧 (Nasogastric tube intubation)	操作型技巧 (Procedural Skills)	1.說明放置鼻胃管之適應症。 2.說明放置鼻胃管之禁忌症。 3.放置鼻胃管(選擇正確鼻胃管尺寸大小、正確擺位、確認鼻胃管位置適當)。 4.說明放置鼻胃管可能之併發症,並早期發現及給予適當處理。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV
Clerk	喉拭樣的操作	操作型技巧	1.說明喉頭培養的必要性及備好採集	評分表	IV

學員	技能	類別	訓練內容	評估方式	Level
	(Throat swab)	(Procedural Skills)	器械、適當的自我防護。 2.採集檢體(避免引發患者嘔吐反射、避免碰觸到舌頭或頰黏膜)。 3.說明運送檢體的注意事項。	OSCE 模擬考 模擬病人	
Clerk	開立處方 (Write a prescription)	治療的技巧 (Therapeutic Skills)	1.具備開立處方的基本概念,包括藥名、劑量、頻率及給予方式。 2.說明每一個處方藥物之效用及副作用。 3.遵守政府藥物管制法令,並能夠在實際開立處方時,適切地運用。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV
Clerk	靜脈輸液的選擇 (Prescribe intravenous fluids)	治療的技巧 (Therapeutic Skills)	1.依據病情之需要,開具適當及適量的靜脈輸液醫囑。 2.說明靜脈輸液的成份、熱量及電解質含量。 3.說明靜脈輸液中,是否可以同時輸注其他藥物。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV
Clerk	靜脈輸液的建立與給予 (Set up a venous infusion)	治療的技巧 (Therapeutic Skills)	1.依據標準步驟,在適當部位消毒及建立靜脈輸注管道。 2.計算正確的靜脈輸液流速。 3.注意不同的靜脈輸液,是否可以經由同一輸注管道輸注。 4.監測病人輸注後是否有不良反應。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV
Clerk	如何監控血中藥物濃度 (Monitor serum drug levels)	治療的技巧 (Therapeutic Skills)	1.說明哪些藥物,應做血中濃度監測。 2.說明各種藥物抽血的時機。 3.判斷濃度適當,並根據血中濃度調整藥物。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV
Clerk	溝通能力(包括與高齡與兒童病患溝通的能力) (Communication skills)	其他的技術	1.會適切地與病人及其家屬溝通,以及詢問病史、說明診斷及處置計畫。 2.以病人聽得懂的語言,解釋檢查結果,並且適當說明病情及其預後。 3.適切地給予病患及家屬關懷與支持。 4.與上級醫師或其他醫療團隊同仁,有適當的溝通及討論。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV
Clerk	提供病人衛教的能力 (Patient education)	其他的技術	1.以病人為出發點。 2.與病人發展夥伴關係,並讓其參與治療計畫 3.使病人容易瞭解衛教內容:用病人的語言、內容具體簡單、雙向溝通等。 4.結束衛教時,能作出簡短的摘要,並提出適當的追蹤計畫。並確認病患及家屬是否充分了解。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV
Clerk	搜尋及選取正確醫療資訊的能力 (Literature appraisal)	其他的技術	說明並且執行「實證醫學」五大步驟: (1)提出適切的問題, (2)找合適的資料, (3)分析、判斷資訊的正確性, (4)資訊於臨床案例的應用,	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	V

學員	技能	類別	訓練內容	評估方式	Level
			(5)評估執行成果。		
Clerk	口述報告 (Presentation) 的能力 (Bedside and conference)	其他的技術	1.獨立整合臨床病症的知識、問診及身體診察的結果，並且能完成邏輯清晰的口頭報告。 2.注意聽眾反應，並掌握時間。 3.適時提問、尋求回饋與改進。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	V
Clerk	團隊合作的能力 (Team work)	其他的技術	1.說明團隊組成份子的角色。 2.說明醫師於醫療團隊中的工作以及與其他專業人員的互動關係。 3.能夠參與跨領域團隊合作，共同照顧病患，完成醫療工作。 4.有效地與團隊成員溝通，並且尊重其他團隊成員。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV
Clerk	書寫的能力 (Documentati on)	其他的技術	1.詳實並正確撰寫住院記錄(包括接班摘要及出院摘要)。 2.詳實並正確撰寫門、急診病歷。 3.詳實並正確撰寫會診申請單。 4.正確撰寫醫囑。 5.正確撰寫乙種診斷證明、出生與死亡證明及法定傳染病通報單之書寫格式。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV

陸、考評機制

以醫策會制定之畢業前一般醫學訓練「學習護照」，做為學員學習歷程之檢核。另訂有：

醫五(Clerk)	醫六(Clerk)
1. 學習護照 (25%)： 學生依據平時學習須完成電子護照，並紀錄心得及回饋。 2. 臨床技能護照(25%)： 3. 病歷寫作 (20%)： 各次專科一份電子修改病歷。 4. 考核表 (20%)： 由指導老師就 clerk 之基本知識、臨床技能、病歷記載、溝通技巧和敬業精神進行評估綜合評分。(於每一次專科結束當週評分) 5. 胸部 X 光及心電圖判讀競賽 (每月/1 份) (10%)	1. 筆試(20%)： 實習最後一週舉行考試 2. OSCE 考試 (20%)： 醫學校院聯合臨床技能測驗。 3. 學習護照(15%)： 學生依據平時學習須完成電子護照，並紀錄心得及回饋。 4. 臨床技能護照(15%) 5. Mini-CEX (5%)：實習結束前於一般內科老師指導學生進行一次 mini-CEX 的評量，並將評量及回饋貼於護照上。 6. 考核表：(15%) 由指導老師就學生之基本知識、臨床技能、病歷記載、溝通技巧和敬業精神進行評估。(於每一次專科結束當週評分) 7. 胸部 X 光及心電圖判讀競賽(每月/1 份) (10%)

柒、教學回饋

師生座談及回饋：

實習期末學生與學科主任、課程負責人、內科總醫師進行座談會交換意見及填寫回饋表。(如附件二、三)

附件一、實習醫學生訓練考核表
佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院
【實習醫學生訓練考核表】

094.12 制訂
 097.09 第一次修訂
 103.05 第二次修訂

☐醫五 Clerk ☐醫六 Clerk ☐醫七 Intern ☐其它_____

原屬學校：_____

受訓時間：自____年____月____日

訓練單位：_____

受評學生姓名：_____

至____年____月____日

考 核 項 目		評 核 標 準 劣 ← → 優	備 考
病人照護 (25%)	1. 病歷寫作的能力 (完整及正確的病史詢問；徹底和適當的身體檢查；可知開立適當的實驗室和影像學檢查；整合有意義和連貫訊息並產生適當的鑑別診斷)	0102030405	【注意事項】 一、本院住院醫師 評核標準係以 等第 A、B、C、 D、E 為基準。 二、評分總結等第 基準依下列原 則進行： A：卓越(總分 90-100 分) B：良好(總分 80-89 分) C：一般(總分 70-79 分) D：尚可(總分 60-69 分) E：差(總分 59 分以下) 三、評核 第四大項 「特殊事項或 貢獻」請務必陳 述具體事蹟，並 決定加減之分 數。
	2. 評估問題及患者照護的能力 (開立病人適當的評估和治療計劃；有效地鑑別和處理臨床問題；清楚及適當的處置計劃並持續照護病人)	0102030405	
	3. 診斷和治療決策的能力 (統整證據並作出診斷和治療決策；適當的利用專科會診；利用可用的資源來支持治療決策；團隊合作以確保及時的診斷及治療)	0102030405	
	4. 緊急臨床問題處理的能力 (快速處置突發的臨床情況；若無法處理能往上呈報)	0102030405	
	5. 臨床技能訓練的能力 (對臨床技能可了解適應症、禁忌症及併發症且能正確執行)	0102030405	
醫學知識 (15%)	1. 連結基礎科學與最新臨床知識的能力 (了解和探討疾病產生的病理生理學；有智慧地討論、診斷、評估及治療疾病；有邏輯能明白可由不同方法解決臨床問題；可搜索最近的文獻和提問尋找最新的醫學知識解決臨床問題)	0102030405	
	2. 利用知識和思考解決臨床問題的能力 (能採用有效的知識、技巧、適當的分析方法來解決臨床問題)	0102030405	
	3. 了解疾病最新臨床指引(guideline)的能力 (了解最新國際及台灣的臨床指引，並應用於病人照護)	0102030405	
工作中學習 及成長 (15%)	1. 討論最新之醫學訊息及科學文獻的能力 (能夠學習、學習如何解決本身學習上的障礙或弱點；從文獻資料搜尋；批判研究文獻並評估是否可應用於病人照護；利用圖書館資源以幫助學習)	0102030405	
	2. 改善病人醫療照護品質的能力 (由不同反饋改變本身態度及照護行為；應用新的技能或知識改善工作的醫療品質)	0102030405	
	3. 協助其他醫療專業人員學習的能力 (不藏私將所學提供給提問者)	0102030405	
人際及 溝通技能 (15%)	1. 病患、家屬溝通的能力 (傾聽病人告訴；採用非專業性語言鼓勵提問和解釋檢查結果；患者或家屬在決策時能傾聽及解釋清楚；並取得知情同意)	0102030405	
	2. 醫療專業人員溝通的能力 (保持完整和清晰的醫療記錄病歷；寫清楚和簡潔的會診記錄；將患者問題組織與簡潔的呈現；提供清楚、明確的資訊)	0102030405	
	3. 醫療團隊合作的能力 (考慮其他醫療團隊成員處境；傾聽其他醫療團隊成員的意見；建設性地協商和處理醫療團隊成員歧見)	0102030405	
專業素養 (15%)	1. 誠信、道德的能力 (堅持守密、尊重病人的隱私與自主、正直及知情同意之原則)	0102030405	
	2. 責任、完成任務、與利他行為的能力 (認識自己的能力的極限；在需要幫助時能請求幫忙；適時的轉診(會診)病患；對病人、社會及本業負責)	0102030405	
	3. 對病人及同儕表現同理心的能力 (體諒病人及家屬的情緒；尊重病人的權利及同儕於性別、年齡、文化、種族、宗教、殘障、社會經濟地位或生命表現出敏銳及認同)	0102030405	
制度下之 臨床工作 (15%)	1. 考慮成本效果最佳化下，發展對病患最佳照護計劃的能力 (考慮成本、檢驗、治療方法的好處；建立病人照護途徑；不進行不必要的檢查)	0102030405	
	2. 促進病人安全的能力 (減少因制度造成醫療的錯誤；回應病人照護的問題；接受來自病人照護團隊的建議，以確保病人的安全)	0102030405	
	3. 與其他醫療照護團隊合作的能力 (與護理、社工、藥事、放射、營養、行政等醫療團隊成員合作解決問題)	0102030405	
特殊事項 或貢獻 (加減 5 分)	☐ 加____分 ☐ 減____分		
評語或 建議	※此部份不得空白		
學員是否須協助轉介諮商 ☐ 否 ☐ 是，原因：_____			
指導主治醫師：		科(部)主任 _____ 年 月 日	

附件二、實習醫學生對臨床教師回饋表

財團法人佛教慈濟綜合醫院實習醫學生對臨床教師回饋表

受評估老師：_____ 受訓時間：自____年____月____日至____年____月____日

受評估科別：_____ 學員：☐醫五 Clerk ☐醫六 Clerk ☐醫七 UGY ☐其他_____

考 核 項 目		評 核 標 準				
		非常不同意 ←————→ 非常同意				
一、醫學知識	1.老師具有專業的醫學知識	○1	○2	○3	○4	○5
	2.老師教學融合了基礎與臨床醫學知識	○1	○2	○3	○4	○5
	3.老師在臨床醫療診治不夠融入實證醫學概念	○1	○2	○3	○4	○5
二、教學技巧	1.老師的教學目標清楚明確	○1	○2	○3	○4	○5
	2.老師不夠尊重學員	○1	○2	○3	○4	○5
	3.老師給了我建設性的回饋	○1	○2	○3	○4	○5
	4.老師在床邊教學指導病史詢問與身體評估份量太少	○1	○2	○3	○4	○5
	5.老師妥善運用問題導向學習	○1	○2	○3	○4	○5
三、教學活動	1.老師確實執行排定之教學活動	○1	○2	○3	○4	○5
	2.老師指導修改過我書寫的病歷	○1	○2	○3	○4	○5
	3.老師讓我有機會事先預習教學內容	○1	○2	○3	○4	○5
四、 全人的 醫療 素養	1.老師是個能盡心照護病人的醫師	○1	○2	○3	○4	○5
	2.老師能與病人/家屬充分溝通	○1	○2	○3	○4	○5
	3.老師對醫學倫理與社會層面的議題關注不夠	○1	○2	○3	○4	○5
	4.老師能夠整合團隊成員意見具有帶領團隊的能力	○1	○2	○3	○4	○5
五、 整體 能力	1.在老師指導下我樂於發問	○1	○2	○3	○4	○5
	2.在老師指導下我的專業能力獲得提升	○1	○2	○3	○4	○5
	3.在老師指導下我有充裕時間與老師互動	○1	○2	○3	○4	○5
	4.在老師指導下我能夠自我學習	○1	○2	○3	○4	○5
六、 總結 與 整體 建議	我是否推薦老師繼續從事教學	☐ 是		☐ 否		
	A：卓越(總分 90-100 分) B：良好(總分 80-89 分) C：一般(總分 70-79 分) D：尚可(總分 60-69 分) E：差(總分 59 分以下)					
	請務必勾選評分總結等第 ☐ A(卓越) ☐ B(良好) ☐ C(一般) ☐ D(尚可) ☐ E(差)					
	整體建議(※請務必填寫並給予具體明確的建議，勿用情緒性字眼)					
	其他意見：					

E6A0021890-03

評分日期：____年____月____日

請學員訓練後立即完成評核，並送交教學部，俾便辦理成績登錄。

附件三、實習醫學生對科(部)教學回饋表

94.12 制訂
97.09 修訂
101.07 四修

受評估科別：_____ 受訓時間：自____年____月____日至____年____月____日

學員：☐醫五 Clerk ☐醫六 Clerk ☐醫七 Intern ☐其他_____

考 核 項 目	評 核 標 準					無法 評核
	非常不同意		←→		非常同意	
1. 提供新成員 orientation 說明課程內容與執行方式	○1	○2	○3	○4	○5	○
2. 該科有明確教學負責人負責安排學生實習	○1	○2	○3	○4	○5	○
3. 確實執行教學活動	○1	○2	○3	○4	○5	○
4. 教學活動分配比重適當	○1	○2	○3	○4	○5	○
5. 門診教學品質良好(含教學門診)	○1	○2	○3	○4	○5	○
6. 住診教學良好(含床邊教學)	○1	○2	○3	○4	○5	○
7. 手術教學良好(含技能教學)	○1	○2	○3	○4	○5	○
8. 實證醫學教學良好	○1	○2	○3	○4	○5	○
9. 病歷寫作教學良好	○1	○2	○3	○4	○5	○
10. 醫學倫理教學良好(知情同意)	○1	○2	○3	○4	○5	○
11. 學習疾病種類豐富多樣	○1	○2	○3	○4	○5	○
12. 科內學習時間充裕	○1	○2	○3	○4	○5	○
13. 值班數合理	○1	○2	○3	○4	○5	○
14. 臨床學習與工作負荷比重分配適切	○1	○2	○3	○4	○5	○
15. 評核制度公平合理	○1	○2	○3	○4	○5	○
16. 科部對學員提出問題能適時回應並處理	○1	○2	○3	○4	○5	○
17. 我對個人在該科學習感到滿意(整體學習價值)	○1	○2	○3	○4	○5	○

評分結果以可評核項目之加權計算。(例：可評核項目共 60 分(滿分 75 分)，加權後總分為 60/75*100=80 分)
A：卓越(總分 90-100 分) B：良好(總分 80-89 分) C：一般(總分 70-79 分) D：尚可(總分 60-69 分) E：差(總分 59 分以下)

請務必勾選評分總結等第 ☐A(卓越) ☐B(良好) ☐C(一般) ☐D(尚可) ☐E(差)

12.在本科(部)學習到的重點為何?(※請務必填寫並給予具體明確的建議，勿用情緒性字眼)

13.請摘要說明本科(部)有何需改進之處?(※請務必填寫並給予具體明確的建議，勿用情緒性字眼)

評估日期：____年____月____日

請學員訓練後立即完成評核，並送交教學部，俾便辦理成績登錄。

E6A0021C04-01